REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Hemorragia Digestiva

Alta e baixa: estabilizar, estratificar, localizar e tratar em uma página

MAIS COBRADO

- **1º Glasgow-Blatchford 0–1** = alta
- **2º Úlcera**: o aspecto na EDA define
- **3º Varizes**: vasoativo + ATB + ligadura
- **4º HDB**: índice de choque e Oakland

1 Alta × baixa

divisor: ângulo de Treitz

Sinal	O que é	Sugere
Hematêmese	Vômito com sangue vivo ou em borra de café	HDA
Melena	Fezes negras, pastosas e fétidas (sangue digerido)	HDA
Enterorragia	Fezes feitas de sangue, coágulos	HDB ou **HDA maciça**
Hematoquezia	Sangue vivo nas fezes	HDB (reto, ânus)

Estabilizar primeiro: ABCDE, 2 acessos calibrosos, cristaloide, **concentrado de hemácias se Hb < 7** (< 8 no cardiopata; varizes: alvo ~8). Corrigir coagulopatia, suspender antitrombóticos quando possível. **Ácido tranexâmico não** (HALT-IT).

2 HDA: estratificar e tratar

Causas: úlcera péptica (37–55%), erosões, varizes (10–23%), esofagite, Mallory-Weiss. **Glasgow-Blatchford** (antes da EDA: ureia, Hb, PAS, FC, melena, síncope, hepatopatia, IC): **0–1 alta** ambulatorial · ≥ 2 interna. **Rockall** usa a EDA e prediz ressangramento e morte. **EDA em até 24 h** (12 h no alto risco); eritromicina 250 mg EV antes.

Úlcera: sangramento ativo ou **vaso visível** → terapia endoscópica + IBP alto (80 mg + 8 mg/h por 72 h) · coágulo aderente: sem consenso · mancha plana ou base limpa → só IBP. **Adrenalina nunca sozinha** (+ térmico ou clipe). Ressangrou: repetir EDA → embolização → cirurgia. Úlcera duodenal posterior (a. gastroduodenal) é de alto risco. Alta: IBP, tratar H. pylori, tirar AINE. **Mallory-Weiss:** 90% param sozinhos. **Dieulafoy:** artéria sob mucosa normal.

3 HDA varicosa

cirrose · alto risco, UTI

Hipertensão portal (gradiente > 10 mmHg). 1/3 das varizes sangra; cada episódio mata 20–30%. Morre-se da falência hepática. **Child-Pugh:** bilirrubina, albumina, INR, encefalopatia, ascite (A 5–6 · B 7–9 · C 10–15).

1. **Vasoativo já** (octreotida ou terlipressina) · 2. **Antibiótico 7 dias** (norfloxacino ou ceftriaxona) · 3. **Ligadura elástica** · 4. Refratário: **Sengstaken-Blakemore** (ponte, máx. 24 h, intubar) e **TIPS** (> 90%; encefalopatia). Prevenção: **betabloqueador não seletivo** + ligadura seriada.

4 HDB

~25% das hemorragias digestivas

Causas: doença diverticular (principal > 70 anos; 80% para sozinha) e **angiodisplasia** nos idosos; hemorroida, fissura, câncer (> 50), DII, pólipos. **Índice de choque** (FC/PAS) > 1 → **angioTC** → embolização em até 60 min; negativa → EDA (11–15% têm fonte alta). Estável: **Oakland ≤ 8** alta com colonoscopia ambulatorial; > 8 interna.

Colonoscopia após estabilizar é o exame de escolha (clipes no divertículo). Angiodisplasia: plasma de argônio, octreotida. Não controlado: arteriografia com embolização → cirurgia: **segmentar** se o local é conhecido, **colectomia subtotal** se não. Fissura: dor lancinante + sangue no papel; hemorroida interna: sangue vivo indolor.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Enterorragia com choque** pode ser HDA: afaste a fonte alta antes do cólon.
2. **Ureia sobe na HDA**: sangue digerido é carga proteica.
3. **Glasgow-Blatchford** é antes da EDA; **Rockall completo** usa a EDA.
4. **Adrenalina isolada** não basta na úlcera.
5. **Base limpa** não leva terapia endoscópica.
6. **Vitamina K sozinha** não reverte sangramento grave por varfarina.
7. **Transfundir demais** nas varizes aumenta a pressão portal.
8. **Balão de Sengstaken** não funciona no Mallory-Weiss (é arterial).
9. **Hemorroida** não explica HDB volumosa sem excluir outras causas.
10. **Cirrótico sangrando** recebe antibiótico profilático.
11. **Ácido tranexâmico** não é rotina na hemorragia digestiva.

Números que caem

Hb alvo **7** (cardiopata **8**) · Blatchford **0–1** alta · EDA < **24 h**
IBP **80 mg + 8 mg/h** por **72 h** · ATB na cirrose **7 dias**
Índice de choque > **1** · Oakland ≤ **8** · Sengstaken máx. **24 h**

Elaborado pela MedSum com base no resumo de hemorragia digestiva do 8º semestre (aula do eixo temático; ACG 2021; BSG 2019; HALT-IT 2020; Schwartz; Sabiston).